<2020년도 학년말고사 내과>

60문제 중 57문제 복원

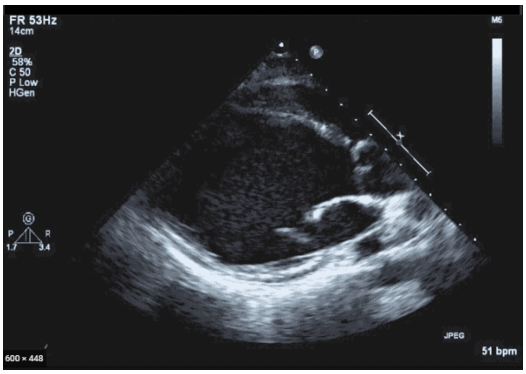
60문제를 45분동안 풀어야했고, 심장, 호흡기내과에서 폭풍 시각자료+대거 탈야마로 시간이 매우 촉박해 검토는 커녕 손을 떨며 보는 시험이었습니다..

<심장내과>

총 10문제 중 8문제 복원

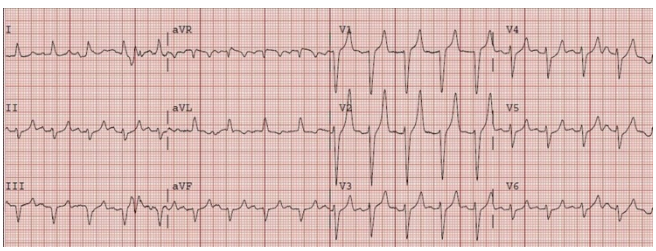
심전도 때문에 따로 복기했습니다.. 대거 탈야마..

1. 20 세 남자가 축구를 하면서 뛰면 가슴이 아파 내원.
   식은땀 나고, 쓰러질 것 같은 느낌 .쉬면 호전된다.
   심초음파주고, 답 옳은 것은?(답논란)



① Afib 이 진단시점에 발견된다.
② 감염성 심내막염을 예방해야한다.
③ 운동시 혈압이 떨어지면 급사위험인자이다.
④ 좌심실유출로의 압력차가 클수록 급사 위험이 높다.
⑤ 증상이 빈번하고 심할 수록 급사의 위험이 높다.

2. Tall T wave, Hyperkalemia 소견을 보이는 EKG 주고 다음 처치는?

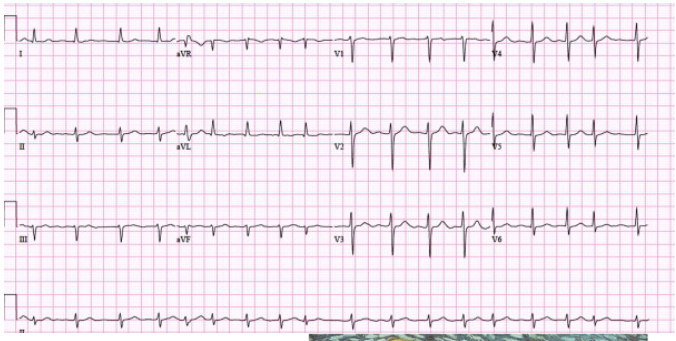


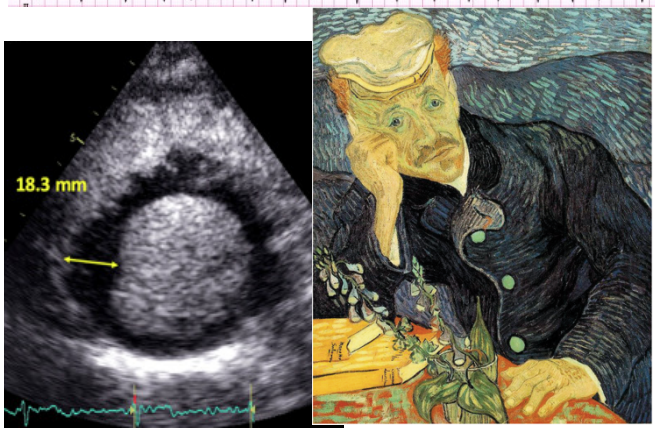
① Ca gluconate 를 투여한다.

3. 46세 여자 어지럽고 두근거림으로 내원. 2년전 비허혈성 심근병증으로 진단.

   V/S 87/57-130-25회, 심초음파에서 LA,LV 확장소견 보임. A-fib으로 보이는 ekg. EF:41%

   (고흐 그림. 힌트로 줌), 쓸 수 있는 약물은?





① neprilysin inhibitor
② flecainide
③ 아미오다론
④ diltiazem
⑤ 디곡신

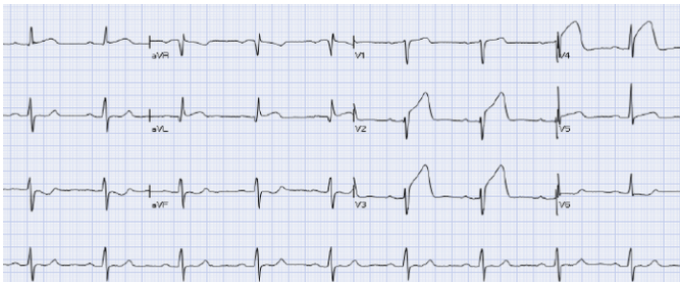
4. ?세 여성이 호흡곤란으로 내원함. HR 45, 이외 BP 등 정상. 치료는?

   (EKG상 Mobitz II 2도방실차단 혹은 sick sinus syndrome 소견이었습니다.)

① 영구형 심박동기

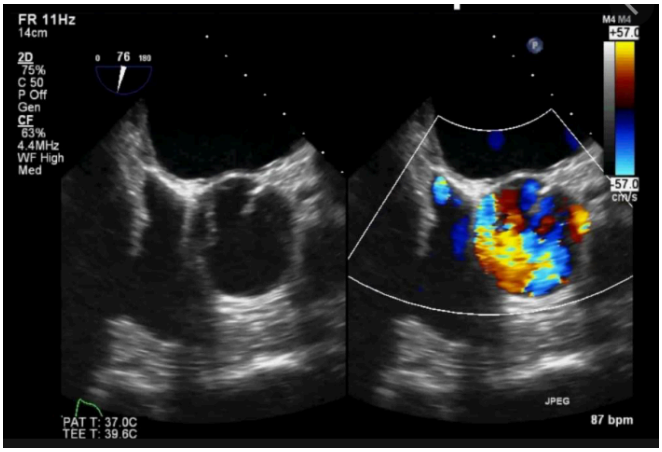
5. 20분전 의식 잃은 남자, 주변사람이 지나가다 심폐소생술 하고, 병원와서 2회 제세동 실시 후 ROSC. 심전도 다음과 같다. V2-V6 에서 ST elevation 소견 .

   V/S 115/71-80-15회 이후 필요한 조치는?



① 일시형심박동기
② 응급심혈관 조영술
③ 삽입형제세동기
④ 혈전용해제
⑤ ECMO

6. 이완기 심잡음이 들리고, LVEF 38%였다. TTE도 주고 TEE도 줬습니다. Aortic aneurysm 4.59cm, aortic regurgitation 초음파 주고 치료는?



① 수술적 대동맥판막 치환술
② 수술적 승모판막 치환술
③ 심실중격결손 교정
④ 동맥관 교정

7. 30년 동안 DM 환자. 걸을 수록 심해지는 통증으로 내원. 혈액검사 상 HbA1c 7.0 이외 이상 없고 (D-dimer 등 주어지지 않음), ABI 0.7/1.0 주어지고, 영상에서 abdominal aorta -> iliac artery에 occlusion 보임. 치료는?





① 혈관성형술
② 혈전용해제

8. ?세 여성이 일을 할 때 심해지는 호흡곤란으로 내원함. 검사 상 LA, RA와 RV 커져있는 소견 보임. 심초음파 사진 주어짐. 진단은?

   (초음파 사진 상 ↙Aortic valve 적혀있었고 그 옆으로 mosaic jet 보였습니다. 낚시인지 힌트인지…)

① 승모판역류
② 승모판협착
③ 대동맥판역류
④ 대동맥판협착
⑤ 심실중격결손
⑥ 심방중격결손

<호흡기알레르기내과>

총 10문제 중 10문제 복원

9. 20대 남자가 알레르기 치료를 받으러 병원에 왔다. 집먼지진드기에 대한 면역치료요법을 시도하던 중 갑자기 호흡곤란이 발생하면서 혈압이 84/50으로 내려갔다. 이에 대한 치료는?

   ① epinephrine

   ② prednisolone

   ③ antihistamine

10. 70대 남자가 최근 숨이 차서 병원에 왔다. 40년 전 천식을 진단받았으며 현재 budesonide + formoterol 흡입제로 조절 중이다. 60년전부터 흡연하였고 20년전 금연하였다. 최근 며칠간 낮에도 숨이 차고 기침도 심해졌다고 한다. 추가해야 할 치료제는?

    ① oral prednisolone

    ② oral montelukast

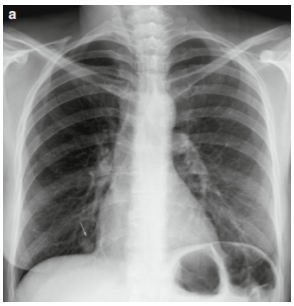
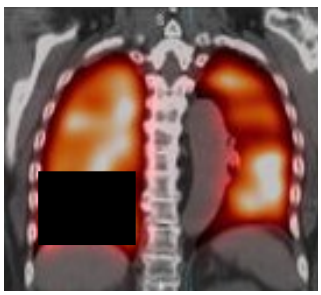
    ③ oral antibiotics

    ④ inhaler tiotropium

11. 만성적인 기침과 가래가 있어서 병원에 왔다. 객담배양(-)

    X ray 정상

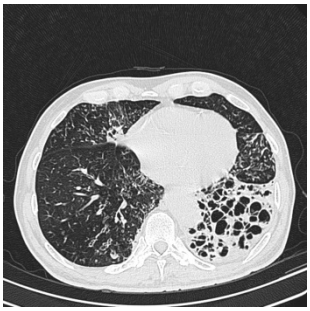
    확산능 SPECT (아래 사진과 유사. 출제는 LLL쪽만 빨갛지 않았음). 진단은?

    ① 기관지확장증

    ② 폐색전증

12. 만성적인 기침과 가래가 있어서 병원에 왔다. 항생제를 먹을만큼 매년1~2회 입원치료를 받아왔다. 발열(-) 객담배양(-). 이에 대한 치료는?



    ① 거담제

    ② 폐엽절제

    ③ 항생제

    ④ 기도위생

13. 몇 개월 전부터 숨이 차다고 병원에 왔다. 평지를 100m 걸으면 숨이 차서 멈춰 쉬어야 했다. 증상이 악화되어 동네 병원에서 항생제를 처방받아 먹은적이 1회 있고 입원한 적은 없다. 폐기능 검사 상 FEV1 61%이다. 치료는?(답논란)

    ① LAMA+LABA

    ② LAMA

    ③ LABA

14. 중년 남자가 호흡곤란을 주소로 응급실에 내원하였다. 과거력 상 만성폐쇄성폐질환을 진단받았다. 자택산소치료를 받고있으며 순응도는 좋다. 최근 숨이 찬 증상이 악화되었다. 의식은 명료하며 혈압 120/80 이었다. 산소공급을 해도 동맥혈가스분석 결과는 pH 7.2 $PaCO_2$ 80mmHg, PaO_2 110mmHg, HCO_3^- ??, Base Excess ?? 이었다. 이 환자의 처치로 알맞은 것은?

    ① 고유량 비강캐뉼라

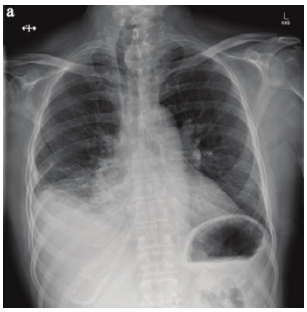
    ② 비침습적양압환기

    ③ 기관삽관 후 인공호흡

15. 중년 남성 숨쉬는데 불편하여 병원에 왔다. 숨을 들이마시면 통증이 있다. 검사결과,

흉수: glucose 100, lymphocyte 80%, 젖산 탈수 효소 상승, 아데노신탈아미노화효소 150, 객담: 항산성도말(-), 결핵PCR(-)

X ray (LML 쪽 effusion과 small mass??) 치료는?

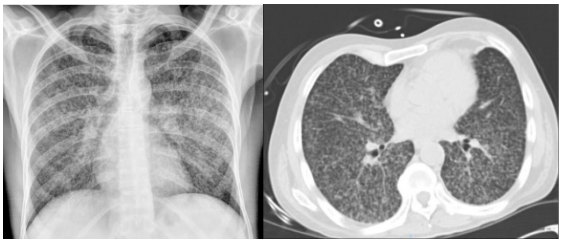


① 항결핵제

② 항생제

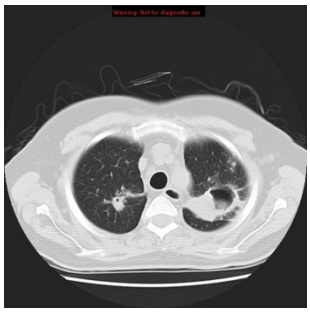
③ 가슴관천자

16. 30대 여자가 수주간 기운이 없고 미열이 있어 병원에 왔다. 기침과 가래는 가끔 있었으며 체온 37.3도이며 그 외 V/S 정상. 진단은?



① 속립결핵

17. 72세 남자가 몇 달간 기침과 가래가 있어 병원에 왔다. 25세에 결핵치료를 받았다. 현재 검사결과, 객담 항산성도말(+) 결핵PCR (-)이다. 옳은 처치는?



① xpert MTB/RIF 검사를 한다.

② 리팜핀, 클라리쓰로마이신, 에탐부톨 3제요법 치료를 시작한다

③ 객담 배양검사를 확인한다.

④ 항생제 내성 검사를 한다.

E.

18. 객혈이 있어 병원에 왔다. 흉부 X선 사진에 결절이 보여 조직검사와 전신핵의학스캔을 진행했다.

핵의학스캔 상 원격전이는 없었을 겁니다…

조직검사: 폐선암 변이: EGFR 변이(-), ALK 변이(+) 기타 다른 변이들 (-)…

① adalimumab

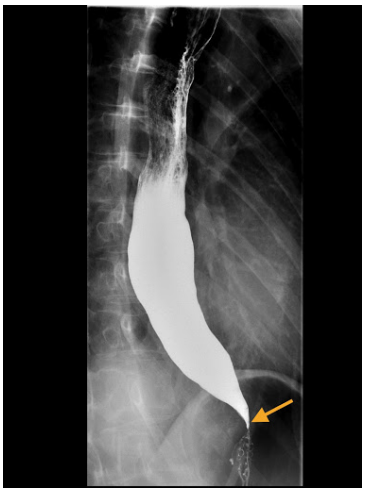
② pemetrexed/cisplatin

③ crizotinib

<소화기내과>

총 10문제 중 10문제 복원

19. (야마) 삼킴장애가 있어 내원하였다. 바륨조영술 검사 상 다음과 같은 소견이 관찰되었다. 환자의 증상을 완화하기 위해 가장 적절한 치료 방법은? (이오영 p)



① 풍선 확장술

② Nissen fundoplication

③ 위산 억제술

④ 경화제 주입

⑤ 내시경적 절개술

20. B 형 간염을 앓고 있는 사람, Child-Pugh Score A 이다. <3cm 의 결절이 발견되었다. 혈관 침범이나 주변 림프절 전이는 관찰되지 않는다. 이 사람에게 적용할 수 있는 간암의 근치적 치료가 아닌 것은?

① 간이식
② 간절제
③ RFA
④ 전신항암요법

21. B 형 간염 바이러스 표면 항원 양성이고 기저질환 당뇨 고혈압 있는 환자, 간종양이 발견되어 내원하였다. 간종양이 우상엽 2.8cm, 좌하엽 2.3cm 의 크기였으며, 위장관 내시경 상 경미한 식도정맥류 소견 있고, 의식은 명료하며 복수는 없다. 혈액검사 수치는 알부민 3.8, 빌리루빈 0.7, INR 1.4 이었다. 먼저 해야 하는 치료는 무엇인가?

① Radiofrequency Ablation

② 간 절제술

③ 간이식

④ TACE

⑤ 전신항암

22. 40/F, 식후 우상복부 통증 호소로 내원하였다. 초음파 사진은 다음과 같았다. (석회화 담낭, 담석 큰 것 존재하였음) 이 환자에게 적합한 치료는 무엇인가?



① 담낭절제술

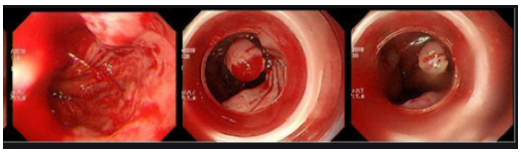
② 경과관찰

③ ERCP

④ 유두괄약근 절개술

⑤ UDCA

23. 중년 남성 혈변을 주소로 내원하였다. 이틀에 1병씩 술을 마셨다고 한다.상부위장관 내시경 상에서 출혈을 확인하고, 다음과 같은 시술을 하였다.(결찰술 한것으로 보임) 현재 환자 활력 징후 및 상태 안정적이다. 추후 출혈 재발을 예방하기 위한 약제로 적절한 것은?



① Terlipressin

② Non-selective beta blocker

③ Diuretics

④ PPI

⑤ Prophylactic antibiotics

24. 20 대 남자, 5 일 전에 답사갔다 왔다고 했는데 4 일 전부터 하루 10 회 설사 나와 내원하였다. 앞으로의 치료를 위해 먼저 해야 할 검사는?

① 대변 백혈구 검사

② 대변 배양 검사

③ 혈액 배양 검사

④ 대장 내시경

25. (야마) 55 세 남자 환자의 건강검진 대장내시경에서 구불결장의 10mm 종괴를 발견하였다. 조직 검사 결과 tubular adenoma 였고 high grade dysplasia (한글로 적혀있었음) 를 보였다. 이 환자의 다음 추적검사는 언제 가 적당하겠는가?

① 5 년

② 3 년

③ 2 년

④ 1 년

⑤ 10 년

26. (야마) 수면 내시경 도중 환자의 산소 포화도가 70%로 갑자기 떨어졌다. 산소를 공급하고 깨웠으나 변화가 없다. 이 때 해줘야 할 조치는?

① 수면제에 대한 길항제를 투여한다

② 산소 투여량을 더 올린다

③ 일단 경과를 보면서 검사를 진행한다

④ 심전도 검사를 시행한다

⑤ 즉시 기관 삽관을 시행한다

27. 34 세 남성이 혈액검사 실시 결과, IgM HAV(-), IgG HAV(+), IgM HBV(-), HbsAg(+), IgG HbcAb(+), IgG HbsAb(-), anti HCV Ab(+), HCV PCR(-)로 나타났다. 이 환자의 진단으로 옳은 것은?

① 급성 B 형 간염

② 만성 B 형 간염

③ 급성 C 형 간염

④ 급성 A 형 간염

⑤ 만성 C 형 간염

28. 환자 흑색변을 호소하여 내원하였고, 위내시경 상 광범위한 출혈이 관찰되었다. 이에 내시경적 지혈 시도 하였으나 시야가 확보되지 않아 실패하였다. 다음으로 해야 할 것은?



① 혈관조영술 및 색전술

② Beta blocker

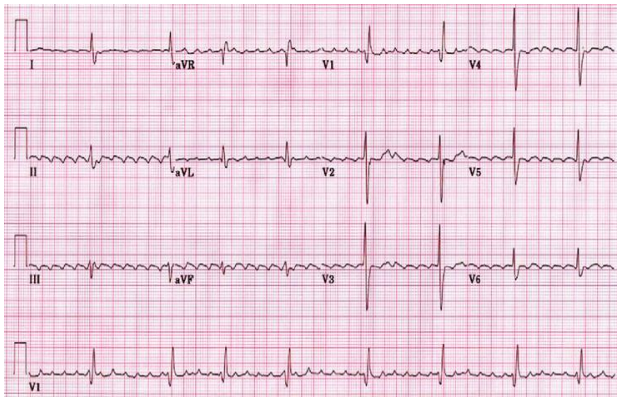
③ Terlipressin

④ PPI

<신장내과>

총 10문제 중 10문제 복원

29. (야마) 63 세 여자, 주소가 혈뇨, 고혈압. 치료받지 않음. 이후에 알고보니 평소 두근거림 있었고, 내원 당시에도 두근거림 있었음. 소변검사 결과와 EKG 결과(A. fib) 보여줌. 다음 중 진단을 위해 시행해야 할 검사는?
[RUA상 혈뇨,단백뇨,Dysmorphic RBC 10%]



① 신혈관 도플러 초음파
② 심장 초음파
③ 관상동맥조영술
④ 조영증강 복부 컴퓨터단층 촬영
⑤ 복부 단순 방사선촬영

30. (야마) 발열(39.3 도 정도)을 호소하며 빈뇨, 잔뇨감, 배뇨통, 소변이 잘 안나오는 여성환자. 신체검사상 좌측 척추각 압통이 있었다. 다음 중 가장 먼저 해야하는 검사는?

① 일반소변검사
② 소변 배양검사
③ 혈액 배양검사
④ 복부 CT
⑤ 복부 초음파

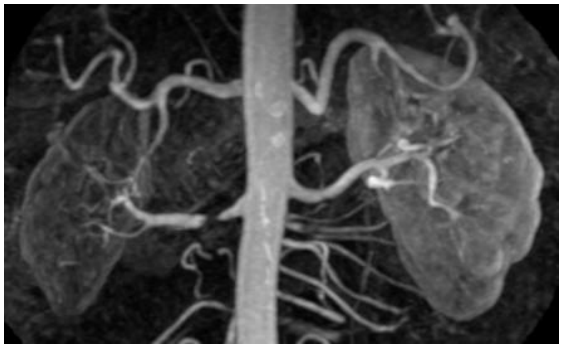
31. (19Y) 60/M 고혈압으로 인해 ESRD 되어 신장이식 받은 환자. 갑자기 다음과 같은 lab 을 보였을때 원인이 되는 약제는?
- plasma glc 690 대
- HbA1c 도 11.0

① Cyclosporine A
② Tacrolimus
③ Mycophenolate mofetil
④ Azathioprine
⑤ Bredinin

32. 심장관련 증상때문에 CAG 및 스텐트삽입 환자, 처음 Cr 13.6/1.2 정도였는데 시술 후 BUN/Cr 81.0/10.8 로 엄청 높아짐. 원인은?

① 조영제로 인한 급성 신세뇨관 산증
② 콜레스테롤 색전증
③ 약물로 인한 renal cortical necrosis
④ 스텐트 시술 중 천공??

33. 고혈압 있는 여자 환자. 혈압은 170/110mmHg 정도. 동네 병원에서 혈압약 먹었는데 조절 안됨. 원인은?
(조영증강 coronal view CT 사진 1 장 있었음 -
시험에서는 Rt.가 아닌 Lt. proximal renal a.가 막힘)



① 신혈관성 고혈압
② 신동맥 혈전증

34. (짤야마) 여성이 육안적 혈뇨로 내원. 엄마, 언니도 같은 증상인데 특별한 문제없이 아주 건강하게 지냈음. 이 환자의 병으로 가장 가능성 높은 것은?.
    ① Thin basement membrane disease
    ② Alport's syndrome
    ③ Membranous glomerulonephritis
    ④ IgA nephropathy

35. (18Y) 마라톤 하다가 쓰러진 여자. hyponatremia(Na 105). 탈수 증상 있었음. 경련 증상은 없었음. 가장 먼저 투여해야 할 수액의 종류는?
    ① 5DW
    ② Hartmann's solution
    ③ 3% saline
    ④ 0.45% saline
    ⑤ 0.9% normal saline

36. Polycystic kidney disease.(transverse view, coronal view CT 사진 2장 줌 - 인터넷에서 비슷한 사진 찾아올립니다) 이 환자의 예후를 좋게하기 위한 치료와 연관된 단백질은?



    ① Na-K-Cl cotransporter (NKCC)
    ② aquaporin-1 (AQP1)
    ③ aquaporin-2 (AQP2)
    ④ epithelial sodium channel (ENaC)
    ⑤ renal outer medullary potassium channel (ROMK)

37. 평상 시에 정상이었던 28 세 남자 환자가 여행을 다녀온 후 설사와 하지 쇠약을 주소로 병원에 내원하였다. 이 환자에 대한 정보가 다음과 같이 주어졌을 때, 환자에 대한 처치로 가장 알맞은 것은?
    - 혈압 : 90/50
    - Serum : Na 135 K 3.5 Cl 98
    - Urine : Na 10 osmolality 800 Cl 20
    ① 5% Dextrose
    ② 10% Dextrose
    ③ Half-isotonic saline
    ④ Ringer lactate solution
    ⑤ Mannitol

38. (야마) IgA nephropathy 의 나쁜 예후인자가 아닌 것은?
    ① 단백뇨
    ② 고혈압
    ③ 육안적 혈뇨
    ④ GFR 감소

<내분비내과>

총 5문제 중 5문제 복원

39. (19연말) 20살 남학생이 공복 혈당 106mg/dl으로 내원하였다. 75g OGTT 소견 30분, 60분, 120분 수치 주어짐. 120분 수치 180mg/dl. HbA1c 6.0%. 상기환자 진단은?

① 정상

② 공복혈당장애

③ 내당능장애

④ 공복혈당장애 + 내당능장애

⑤ 당뇨

40. 38세 남자, 혈당이 높아서 내원. 지속적으로 혈당이 높았으나, 기저질환은 모르는 자. 이 사람에게서 혈당이 오르는 질환으로 가장 가능성이 떨어지는 것은?

① Acromegaly

② Diabetes melliatus

③ Cushing's disease

④ Hyperparathyroidism

⑤ Pheochromocytoma

41. (19연말 변형) 갑상선기능저하증 있어서 levothyroxine 100mg 투약 중인 환자. 치료 중 혈액검사했더니 다음과 같다. 앞으로 치료방침은?

- T4 정상, TSH 참고치보다 증가

① Levothyroxine 현 용량 유지

② Levothyroxine 50mg으로 감량

③ Levothyroxine 75mg으로 감량

④ Levothyroxine 125mg으로 증량

⑤ Levothyroxine 150mg으로 증량

42. 다음 중 갑상선 암 유발 위험인자를 모두 고르시오. (박스형 아님, 모두 고르기)

① 두경부 방사선 조사 과거력

② 갑상선 스캔에서 열결절

③ PET intake 증가함

④ MEN1에서 만져지는 종괴

43. (18연말 변형) 무증상 일차성 부갑상선기능항진증 환자에 대한 소견 제시됨. 부갑상선기능항진증 임상양상 제시됨. 이 환자가 부갑상선 수술을 하게된 적응증에 맞는 소견은?

나이 55세

혈액검사상 Ca 11.8, iPTH 100, GFR 80

24hr Urine Ca 860, GFR 80

DXA 상 L1-4 평균 -2.2, femur neck -2.0

① 나이

② 24시간 소변 Ca

③ 혈중 Ca

④ 골밀도

⑤ GFR

<감염내과>

총 5문제 중 4문제 복원

44. VAP 예방을 위한 방법으로 옳지 않은 것은?(답 논란)
    a. Elevate head of bed to 30-45 degrees
    b. Give "sedation vacation"
    c. Early tracheostomy
    d. Opening suction
    e. Oral decontamination with Chlorohexidine

45. 항생제의 일반적인 사용의 원칙으로 옳지 않은 것은?
    a. 같은 효과일 경우 주사제를 사용한다
    b. 같은 효과일 경우 저렴한 것을 사용한다
    c. 특수한 경우를 제외하고는 narrow-spectrum, 단일약제를 선택한다
    d. 감수성 결과에 따라서 선택한다

46. 물과 비누로 손을 씻어야하는 경우는?
    a. Central venous line insertion을 위해 장갑을 착용하기 전
    b. VRE 환자의 foley bag를 만졌을 때
    c. 6인 병실에 들어갈 때
    d. CRE 환자의 신체 진찰을 하고 난후
    e. C.difficile 환자의 침상을 정리하고 난 후

47. 수술 전 예방적 항생제 사용에 대한 것으로 옳은 것은?
    a. 수술부위 감염을 예방하기 위해 사용한다
    b. 수술 7일 전에는 사용되어야 한다
    c. Broad spectrum 항생제를 사용한다.

<류마티스내과>

총 5문제중 5문제 복원

48. 38세 남성. 1st metatarsophalangeal joint 통증, 압통, 부종. 3개월 전에도 과음 후 같은 증상 있었고, 5일 정도 지속되며 NSAIDs 먹으면 호전됨. 가장 필요한 검사?

    ① 관절액 편광현미경

    ② 관절액 배양

    ③ 관절 초음파

49. 65세 남성. 1st metatarsophalangeal joint 통증. 이전에도 종종 아팠으나 이번에는 자신이 느껴본 최고의 고통이라고 함. 그 외에도 고혈압, 고지혈증 등에 대한 서술이 있었음. 가장 필요한 검사?

    ① 관절 액편광현미경

    ② DECT

    ③ 관절 초음파

50. 40대? 여성. 코 옆날개를 침범하지 않은 양 볼의 rash. 이전에 총 6번 정도 구강 궤양으로 이비인후과 진료 본 적 있음. 무력감, 피로. 오른손 3, 4, 5 PIP joint, 왼손 2, 4 PIP joint 통증. 진단에 중요한 검사?

    ① RF

    ② ANA

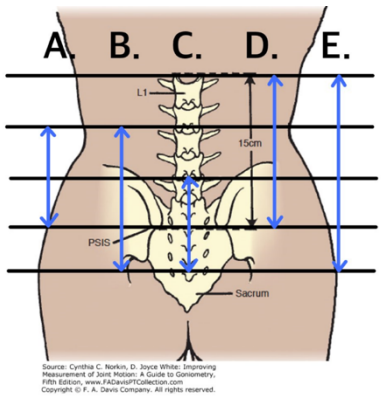
    ③ Anti-CCP

    ④ Anti-dsDNA 등

51. 50대? 여성. 손가락, 손목 통증을 주소로 내원. 이외에도 오른쪽 elbow에도 통증 있었음. 조조강직 있음. 진단은?

    ① 류마티스관절염

52. 24세 남성. 허리, 엉덩이 통증. 조조강직 있음. 진단을 위해 영상의학적 검사를 시행하기에 앞서 관절가동범위를 측정하기 위한 검사를 시행하려고 한다. 올바른 방법은?



    a. A
    b. B
    c. C
    d. D
    e. E

<혈액종양내과>

총 5문제 중 5문제 복원

53. Reticulocyte production index를 구하시오. Reticulocyte 1.41%, hematocrit 15. Hb 5.0. RPI 구할때 사용하는 표도 주어짐. (Hct 45%-1.0, 35%-1.5, 25%-2.0, 15%-2.5)

① 0.1

② 0.2

③ 0.3

④ 0.4

⑤ 0.5

참고: 계산해보면 0.186…나옵니다. 반올림해서 0.2가 답입니다.

54. 56세 여성 3개월 전부터 잇몸에 자주 피가 나고, 멍이 자주 든다 하여 내원하였다. Plt 3000. 적혈구/백혈구 수치 정상. aPTT, PT 수치 다 정상. PBS 검사에서도 다 정상이었다. 비장비대는 없었다. 진단명은?

① 면역 혈소판 감소증

② 파종혈관내응고

③ 혈전혈소판감소 자색반병

④ 범혈구 감소증

55. 다음 환자에서 IPSS 점수에 의한 예후는?

- Karyotype: -7, XY
- BM blast: 4%
- Hb 10.5 WBC 1700 PLT 120,000 ANC 1300

① Low

② Intermediate-1

③ Intermediate-2

④ High

56. 58세 남성이 왼쪽 목에서 만져지는 덩이를 주소로 내원하였다. 체중은 최근 들어 3kg 감소 하였으며 그 이외에 다른 증상은 없었다. 환자의 stage는?

- CT: 목, 종격동, 간, pelvic level의 axial CT 총 네 장 주어졌는데 PET-CT도 아니고 제 기준 아무리 찾아도 목에 림프절 커진것 외에 찾지 못했습니다…간은 완전 깨끗했습니다.
- 검사 결과 엄청 많이 주어졌지만 staging에 중요한 정보: CSF, BM에 involvement는 없음.

① IIB

② IIIB

③ IVB

④ IIIA

⑤ IVA

참고: 3kg 감소한 것은 B Sx에 해당하는 수준의 체중감소가 아니라고 보아 B는 제끼고 A만 있는 선지를 보았을 때 III, IV + A 조합밖에 없었습니다. IV의 경우엔 >2 extranodal 전이나 BM, liver 전이일 경우 줄 수 있는데 텍스트로 BM involve는 없었다 하였고 CT에서 간도 매우 깨끗해서 저는 IIIA를 골랐습니다. 이외 흔한 답은 3kg 감소를 B Sx으로 보아 IIB를 고른 것이었습니다.

57. 43세 남성이 걷거나 계단을 오를 때 숨이 차고 어지럽다 하여 내원하였다. Reti 15%, LDH 증가, total bilirubin 3.5. (수치가 확실하진 않지만 확실한 용혈성빈혈 특징)

① 용혈성빈혈

② 거대적혈모구빈혈

③ 철 결핍 빈혈